Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 9ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810363

Processo nº **0003846-65.2024.8.17.4001**

AUTOR(A): L. D. H. S.

RÉU: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA, HOSPITAL ESPERANCA LTDA.

SENTENÇA

Vistos, etc.

L. D. H. S., representada por sua genitora ALINE DE HOLLANDA DOS PASSOS, propôs a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR em face de AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA, alegando que, embora adimplente com os pagamentos do plano de saúde administrado pela Mount Hermon, o contrato foi rescindido unilateralmente pela ré antes do término previsto (15/11/2024), com suspensão dos atendimentos a partir de 23/10/2024, sem aviso prévio adequado.

A menor, de seis anos, foi diagnosticada com hérnia inguinal esquerda, com cirurgia marcada para o dia 29/10/2024 no Hospital Esperança, já previamente autorizada pelo plano. Com a suspensão do atendimento, a internação foi negada, colocando em risco a saúde da criança. A autora, sem condições financeiras para arcar com os custos do procedimento (R$ 12.000,00), pleiteou a concessão de tutela de urgência para garantir a realização da cirurgia e a manutenção do plano até o fim do prazo contratual, além da concessão da justiça gratuita.

Juntou documentos (ID 186588950 a ID 186588973).

Liminar deferida em regime de plantão (ID 186595838) nos termos requeridos na inicial.

Em ID 186843001, a parte autora informou o descumprimento da liminar.

A parte Ré, Hospital Esperança S/A, apresentou embargos de declaração em ID 187736229, apontando que a parte autora teria induzido este Juízo a erro, uma vez que o laudo médico não declarava a urgência do procedimento.

Citada, a ré, Hospital Esperança S/A, apresentou defesa em ID 189247644. Alega, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, assim como a ilegitimidade passiva do Hospital Esperança, uma vez que a falha na prestação de serviços decorreria da operadora de saúde.

No mérito, reiterou o que afirmou em sede de embargos de declaração, reafirmando que o laudo médico que acompanha o pedido autoral expressava que a cirurgia possui caráter eletivo. Ainda, acrescentou a ausência de nexo causal, já que o ato ilícito apontado pela autora diz respeito ao suposto cancelamento indevido, o que não incluiria a demandada.

Pugnou pela improcedência da ação.

Juntou documentos (ID 189247645 a ID 189247647).

A outra Ré, AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA., também devidamente citada, apresentou contestação em ID 190021391. Aduziu, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, uma vez que foi oportunizado aos autores que migrassem para qualquer dos produtos que atualmente são oferecidos pela Demandada.

No mérito, afirmou que a ré é uma operadora de saúde, empresa que atua no mercado para prover e gerir produtos de assistência em saúde, em caráter suplementar às atividades prestadas pelo Estado por meio do Sistema Único de Saúde – SUS. Declara que comunicou aos clientes que disponibilizou uma nova linha de produtos, ofertados pela administradora com quem contratou para seguir as atividades no mercado de saúde suplementar – a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A ("QUALICORP"), uma vez que teria rescindido unilateralmente o contrato.

Informou que a inadimplência da Mount Hermon superou 10 dias, motivo pelo qual requereu a suspensão imediata do contrato, de modo que não seria possível reintegrar à parte autora a um produto que estaria indisponível.

Pugnou pela improcedência da ação.

Juntou documentos (ID 190021393 a ID 190021403).

HOSPITAL ESPERANÇA S/A interpôs agravo de instrumento (ID 190341659 - Pág. 2).

Não foi apresentada réplica (ID 195370808).

Intimadas as partes para requererem novas diligências, todas pleitearam o julgamento antecipado da lide.

Tendo em vista o interesse de incapaz, o Ministério Público se manifestou em ID 200403349, requerendo a procedência da ação.

É o relatório. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Com relação às preliminares levantadas pelo Hospital Esperança, verifico que a inicial não contempla qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia. Ademais, a respeito da questão acerca da ilegitimidade passiva *ad causam,* vejo que esta também não merece prosperar, uma vez que o nosocômio é unidade de atendimento interligada ao plano de saúde contratado pelo consumidor, restando inafastável, portanto, o interesse jurídico para que figure no polo passivo da lide.

Ainda, com relação à preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela AMPLA PLANOS DE SAÚDE LTDA, como é sabido, o Poder Judiciário não está adstrito a prévio requerimento administrativo para conceder medidas que visem assegurar direitos constitucionalmente previstos.

Portanto, tomando como base os argumentos supramencionados, rejeito as preliminares.

Passo a análise do mérito.

A demanda se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto caracterizada pela relação de consumo estabelecida entre paciente, hospital e plano de saúde.

Nesse ínterim, anote-se que no caso dos autos, verifico que a situação que acomete o Autor diz respeito a procedimento cirúrgico necessário. O médico que acompanha a paciente foi claro no laudo de ID 186588955 ao afirmar que a criança estava sentindo dores e possuía tumoração iguinal esquerda que aumentava consoante os esforços. Logo, ainda que conste no laudo "em caráter eletivo", não há como se afastar a urgência do contexto em que um infante necessita de intervenção cirúrgica para que suas dores possam cessar.

Assim, a necessidade do procedimento cirúrgico é evidenciada pelo relatório médico da autora, que descreve seu quadro inflamatório e de dor aguda, justificando a urgência.

Desse modo, evidente que o plano de saúde, tampouco o hospital não pode interferir na prescrição médica, salvo em casos excepcionais, não configurados nos autos.

Neste contexto, o artigo 35-C da Lei Federal nº 9.656/98, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 11.935/2009, definiu, de modo claro, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos "*de emergência, como tal definidos, os que implicarem risco imediato de vida ou de* ***lesões irreparáveis para o paciente****, caracterizados em declaração do médico assistente*".

O art. 35-C encerra, à evidência, uma prescrição de ordem pública, seja porque procura preservar a vida, bem coletivo por excelência, seja porque regula o serviço de assistência à saúde, em caráter supletivo à oferecida pelo Estado, seja porque quer garantir o cumprimento do fim social deste tipo de contrato. Para além de norma de ordem pública, a disposição do art. 35-C é imperativa, vale dizer de rigorosa observância, de modo que não se admite disposição contratual em sentido contrário nem procedimento diverso ou que limite ou ilida a prescrição legal.

Para a hipótese de procedimento ambulatorial ou hospitalar caracterizado como de urgência ou de emergência, que na essência exige risco sério à integridade física/psíquica, a cobertura é incondicional, irrestrita, sem limites enquanto durar o estado de emergência ou urgência. Esse é o sentido e alcance do art. 35-

C.

Registre-se, por oportuno, que o objetivo do contrato de seguro de assistência médico-hospitalar é o de garantir a saúde do segurado contra evento futuro e incerto, não estando a operadora habilitada, nem tampouco autorizada, a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar a sua vida em risco.

Não se justifica, no atual estado em que se encontrava a autora, ter negado o tratamento cirúrgico necessário ao restabelecimento de sua saúde pela Demandada. Isso porque não pode a autora, menor impúbere, ser responsabilizada pelas fraudes perpetradas pela Administradora, considerando, ainda, que estava adimplente com as parcelas do plano de saúde.

Assim, a discórdia a respeito da necessidade ou não da realização do procedimento deve se resumir ao profissional médico que acompanha o paciente. Não se pode permitir que, no momento de necessidade, pressa e dor sofrido pela parte autora, a Seguradora tenha a opção de obter pronunciamento judicial definitivo sobre a necessidade ou não da realização dos procedimentos, pois que isso fatalmente poderia ocasionar um mal maior ao paciente, inclusive sofrimento e/ou morte.

Cumpre destacar, a princípio, que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar sobre a letra fria do texto a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Outrossim, no feito *sub judice* tem aplicabilidade o Código de Defesa do Consumidor, isso porque qualquer operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços abertos e remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota, conforme entendimento do STJ no RESP 267530-SP, da relatoria do Min. Ruy Rosado de Aguiar – j. 14.12.2000.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

> "RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. 1. Demanda indenizatória proposta por paciente portador da Síndrome de Down, que, com um ano e cinco meses, após ser submetido a cirurgia cardíaca, recebeu indevidamente alta hospitalar, tendo de retornar duas vezes ao nosocômio, com risco de morte, sendo submetido a duas outras cirurgias, redundando na amputação de parte da perna esquerda. 2. A regra geral insculpida no art. 14, "caput", do CDC, é a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. 3. A exceção prevista no parágrafo 4º do art. 14 do CDC, imputando-lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais liberais. 4. Impossibilidade de interpretação extensiva de regra de exceção. 5. O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos é do hospital recorrente por imposição legal (inversão 'ope legis'). Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC. 6. Não tendo sido reconhecida pelo tribunal de origem a demonstração das excludentes da responsabilidade civil objetiva previstas no parágrafo 3.º do artigo 14 do CDC, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 07/STJ, pois exigiria a revaloração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte Superior. 7. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. 8. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - REsp: 1331628 DF 2012/0135921-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 05/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2013)."

Enfim, a empresa Demandada se enquadra como prestadora de serviços, nos moldes do art. 3°, parágrafo 2°, da Lei 8.078/90.

Portanto, cabe ao profissional responsável pelo caso determinar os procedimentos necessários para diagnosticar a doença que acomete o paciente, de modo a proporcionar tratamento apropriado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade.

Ademais, tomando como base os documentos colacionados aos autos, verifica-se que a operadora de saúde emitiu aviso aos beneficiários de que a previsão de encerramento do contrato estava prevista para a data de 15/11/2024, de modo que não foi cumprida a notificação. Isso porque, quando questionada por meio dos canais de atendimento disponibilizados pela seguradora, a autora foi informada que foi emitida nova notificação, a qual não havia recebido, informando aos segurados que, no mesmo dia do envio do aviso - 23/10/2024, os serviços estariam suspensos - ID 186588950 - Pág. 7. Situação que se mostra desproporcional e abusiva.

Por tudo isso, conclui-se que não há exceção legal a amparar o eventual indeferimento de internamento e realização da cirurgia por parte da Ré, sendo devido o pleito requerido.

Diante de todo o exposto e de tudo mais que dos autos constam e pelos princípios aplicados à espécie, e nos termos do CDC, e art. 14, II, do CDC, confirmo a liminar de ID 186595838 - Pág. 4 e **JULGO PROCEDENTE** o pedido contido na ação para condenar as rés, solidariamente, a autorizar o internamento e a cirurgia indicados pelo médico assistente.

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, a serem arcados pela Demandada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a qual inclui também a obrigação de fazer.

Extingo a Ação com resolução do mérito, o que faço com arrimo no art. 487, I, do CPC.

P.R.I.

Recife, 04 de junho de 2025

Ailton Soares Pereira Lima

Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: AILTON SOARES PEREIRA LIMA
05/06/2025 09:50:53
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 206205126

25060509505343600000200829809

IMPRIMIR GERAR PDF